Edema agudo de pulmón

FISIOPATOLOGIA · Clase 23 · del capilar que se llena de presión al alveolo inundado de espuma rosada

1 · QUÉ ES Y CÓMO SE CLASIFICA

F1

Edema agudo de pulmón
acúmulo súbito de líquido en el intersticio y el alveolo; emergencia que daña la hematosis

se clasifica en

Dos tipos
cardiogénico (presión alta) y no cardiogénico (barrera rota u oncótica baja)

2 · CARDIOGÉNICO: FALLA EL VENTRÍCULO IZQUIERDO

F2 · F5

Falla del VI
IAM, HTA, valvulopatía mitroaórtica, miocardiopatía, arritmias, hipervolemia y estenosis aórtica descompensada; el ACV no es cardiogénico

cardiogénico: nace de la

represa la sangre hacia atrás

Mecanismo retrógrado
sube la presión en la aurícula izquierda y en las venas pulmonares

por bajo gasto da

F6 · F18

Extremidades frías
el bajo gasto cierra los vasos de la piel: sudor frío (en el no cardiogénico están calientes)

empuja la presión del capilar a

no cardiogénico: baja la

3 · LOS CUATRO MECANISMOS DEL EDEMA

no cardiogénico: aumenta la

F3 · F8

Presión hidrostática alta
el capilar pasa de 10 mmHg a 25-30 mmHg; sale un trasudado

F16

Presión oncótica baja
normal 25 mmHg; cae en nefrótico y cirrosis por hipoalbuminemia

F4 · F9

Permeabilidad aumentada
sepsis, SDRA, neumonía, tóxicos y anafilaxia: sale un exudado con proteínas

si supera el drenaje, desborda el

retiene menos agua y sobrecarga el

deja salir proteínas y sobrecarga el

F1

Linfático desbordado
drena el exceso al inicio; si la trasudación lo supera, el líquido se acumula

deja el líquido en el

Edema intersticial y alveolar
la hematosis se altera y baja la PO2

por ejemplo, en el

se confirma con la

su desencadenante se halla con el

mezcla aire y sangre y da

por eso el oxígeno pasa por

incluye lo

4 · CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO

Esputo rosado espumoso
espuma con glóbulos rojos; cianosis y respiración estertorosa

ECG
busca el desencadenante: IAM, arritmias o crecimiento de cavidades

F10

Lo agudo
disnea, taquipnea, hemorragia y atelectasia; la fibrosis es secuela tardía

F7

Disnea
síntoma más frecuente: ortopnea y taquipnea

se confirma con la

Radiografía
índice cardiotorácico alto, líneas de Kerley, alas de mariposa y derrame pleural

confirmado, se inician las

Sibilantes y crepitantes
asma cardiaca, luego crepitantes bibasales que suben como marea montante

se confunde con asma, se aclara con el

Diferencial
asma (aquí hay crepitantes, S3 y esputo rosado) y bronconeumonía (fiebre e infiltrado focal)

descartado, se inician las

hace que el paciente se oye como

5 · TRATAMIENTO POR OBJETIVOS

F19

Alcohol al 1/3
el oxígeno pasa por alcohol: rompe la tensión superficial de la espuma

F13 · F14

Medidas generales
sentado con pies colgando, O2 5-7 L/min, vía periférica, monitor y diuresis

si hay emergencia hipertensiva, baja la

si hay hipotensión o FA, mejora la

sigue bajar la

si hay FA rápida, orienta a

si la PO2 sigue baja, hay

F11 · F12

Precarga
furosemida IV 50-100 mg, morfina y nitroglicerina si la PA es normal o alta

Contractilidad
dobutamina si hay hipotensión o shock; digoxina si hay FA rápida

F17

Postcarga
nitroprusiato solo en emergencia hipertensiva (riesgo de tiocianato); hidralazina en embarazada hipertensa

si persiste, produce

facilita la ventilación hacia un

baja la presión y deja un

incluye la

F15

Furosemida
diuresis más venodilatación precoz: baja volumen y presión capilar

sostiene el gasto y deja un

baja volumen y deja un

6 · COMPLICACIÓN Y DESENLACE

Caso típico
varón de 68 años con IAM previo, sentado, esputo rosado y manos frías: cardiogénico

Hipoxemia grave
PO2 menor de 50 mmHg con insuficiencia respiratoria

si falla la oxigenación, se debe

sin tratar lleva a

Intubar y ventilar
soporte ventilatorio cuando la oxigenación falla

Insuficiencia respiratoria
shock y muerte si no se corrige

asegura la oxigenación y deja un

Edema resuelto
se baja la presión y el paciente se estabiliza

síndrome · concepto · causa · mecanismo · signo · síntoma · diagnóstico · técnica · complicación · desenlace · ejemplo · borde dorado = alto rendimiento · F# = pregunta n.º # de la lámina

Fuente: Clase 41 · Dr. Sotito — teoría del docente (= literatura)